

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

PROCEDURA DI GESTIONE E TUTELA DELLA MATERNITÀ

Area 12 – People

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PRO025_01	01	04/05/2026	5
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
P&C / RSGI / RSPP	AD – Francesco Epifani	Interno	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Carolina Bussoletti	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
04/05/2026	04/05/2026	04/05/2026

1. Scopo e campo di applicazione

La presente procedura disciplina le misure di tutela della maternità e della paternità in Toscana Diagnostica, garantendo la piena applicazione della normativa vigente e del CCNL Studi Professionali, la protezione della salute della lavoratrice e del nascituro, e il supporto al rientro al lavoro dopo il congedo. La procedura si applica a tutte le lavoratrici dipendenti in stato di gravidanza, alle lavoratrici madri fino a sette mesi dopo il parto, ai lavoratori padri per i congedi di loro competenza, e ai genitori adottivi e affidatari.

In una struttura sanitaria come Toscana Diagnostica, la tutela della maternità assume una rilevanza particolare per la presenza di rischi specifici (biologico, radiologico, chimico, da postura) che richiedono una valutazione tempestiva e misure organizzative dedicate. La procedura si coordina con la UNI PdR 125 (parità di genere), la ISO 45001 (salute e sicurezza), la PAS 24000 (diritti dei lavoratori) e il Piano Strategico PdG e D&I (TD-SGI-PLN002).

2. Riferimenti normativi

Norma	Contenuto rilevante
D.Lgs. 151/2001	Testo Unico sulla maternità e paternità: congedi, divieti, tutele economiche, diritto al rientro
D.Lgs. 81/2008, art. 28 c.1	Valutazione dei rischi con attenzione alle differenze di genere e alla tutela delle lavoratrici in gravidanza
D.Lgs. 81/2008, Allegato A	Elenco dei lavori vietati durante la gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto
D.Lgs. 101/2020, art. 12	Protezione delle lavoratrici gestanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti
CCNL Studi Professionali (Confprofessioni)	Integrazione al 100% dell'indennità INPS per il congedo obbligatorio (rif. IDL006 Sez. 4.6)
D.Lgs. 198/2006	Codice delle pari opportunità: divieto di discriminazione per gravidanza e maternità
UNI PdR 125:2022	Indicatore 5.3.2: politiche a sostegno della genitorialità e della conciliazione vita-lavoro
PAS 24000:2022	Diritti dei lavoratori: tutela della maternità, non discriminazione, condizioni di lavoro
TD-SGI-PLN002	Piano Strategico Parità di Genere e D&I
TD-SGI-PRO024	Procedura Gestione Risorse Umane

3. Comunicazione dello stato di gravidanza

La lavoratrice comunica lo stato di gravidanza alla funzione P&C non appena ne viene a conoscenza, allegando il certificato medico attestante la data presunta del parto. La comunicazione è trattata come dato sanitario sensibile ai sensi del GDPR: è accessibile esclusivamente alla funzione P&C, al RSPP e al Medico Competente. La comunicazione tempestiva è nell'interesse della lavoratrice, poiché consente l'attivazione immediata delle misure di protezione.

Alla ricezione della comunicazione, la funzione P&C attiva immediatamente: la valutazione dei rischi specifici da parte del RSPP e del Medico Competente (Sezione 4); l'informazione alla lavoratrice sui suoi diritti (congedi, permessi, tutele economiche); la comunicazione all'INPS dello stato di gravidanza (ove previsto); la pianificazione organizzativa della copertura della posizione durante il congedo.

4. Valutazione dei rischi e misure di protezione

4.1 Rischi specifici per le lavoratrici gestanti in Toscana Diagnostica

Rischio	Mansioni esposte	Norma di riferimento	Misura adottata
Rischio biologico (agenti patogeni ematici e non)	Prelievi venosi, manipolazione campioni biologici, laboratorio di analisi, microbiologia	D.Lgs. 81/08 All. A; D.Lgs. 151/01 art. 7	Interdizione dal lavoro a rischio o spostamento a mansione non esposta
Rischio radiologico (radiazioni ionizzanti)	TSRM, infermieri di sala RX/TC, personale di sala RM	D.Lgs. 101/2020 art. 12; PRO011	Obbligo di dichiarazione immediata; allontanamento dall'esposizione; limite dose al

			feto 1 mSv
Rischio chimico (reagenti di laboratorio, fissativi, coloranti)	Tecnici di laboratorio, anatomia patologica (formaldeide, xilene)	D.Lgs. 81/08 Titolo IX; D.Lgs. 151/01 art. 7	Spostamento dalla sezione di anatomia patologica; sostituzione con mansioni non esposte
Movimentazione manuale dei carichi	Personale che movimenta attrezzature, campioni pesanti, materiali di magazzino	D.Lgs. 81/08 Titolo VI; D.Lgs. 151/01	Divieto di movimentazione superiore a 3 kg; riassegnazione delle attività
Postura prolungata in piedi	Accettazione, prelievi, diagnostica per immagini	D.Lgs. 151/01 art. 7 lett. g	Organizzazione di pause aggiuntive; disponibilità di seduta; turnazione delle attività in piedi
Lavoro notturno	Tutte le mansioni con turni notturni (22:00-06:00)	D.Lgs. 151/01 art. 53	Divieto assoluto di lavoro notturno dalla comunicazione della gravidanza fino a un anno di età del bambino

4.2 Processo decisionale

Alla comunicazione della gravidanza, il RSPP e il Medico Competente effettuano entro 5 giorni lavorativi una valutazione individuale del rischio che tiene conto della mansione effettiva, dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro e dello stato di salute della lavoratrice. Gli esiti possibili sono tre: la lavoratrice può proseguire nella mansione attuale senza restrizioni (nessun rischio rilevante); la lavoratrice è spostata a mansione compatibile, con conservazione della retribuzione e dell'inquadramento (rischio eliminabile con spostamento); la lavoratrice è interdetta anticipatamente dal lavoro su disposizione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) quando lo spostamento a mansione compatibile non è possibile. In caso di interdizione anticipata, la funzione P&C trasmette la comunicazione all'ITL con la documentazione attestante l'impossibilità di spostamento.

5. Congedi e permessi

5.1 Schema dei congedi

Istituto	Durata	Trattamento economico	Riferimento
Congedo di maternità obbligatorio	5 mesi (di norma: 2 mesi prima + 3 mesi dopo il parto; oppure 1+4 con opzione flessibilità; oppure 0+5 con certificazione medica)	INPS 80% + integrazione TD al 100% (CCNL Studi Professionali)	D.Lgs. 151/01 artt. 16-27; IDL006
Interdizione anticipata (gravidanza a rischio)	Dalla data del provvedimento fino all'inizio del congedo obbligatorio	INPS 80% + integrazione TD al 100%	D.Lgs. 151/01 art. 17
Interdizione anticipata (lavori vietati)	Dalla comunicazione fino al 7° mese dopo il parto	INPS 80% + integrazione TD al 100%	D.Lgs. 151/01 art. 17
Congedo di paternità obbligatorio	10 giorni lavorativi (utilizzabili dai 2 mesi prima ai 5 mesi dopo il parto)	INPS 100%	D.Lgs. 105/2022
Congedo parentale (facoltativo)	Fino a 10 mesi complessivi tra i due genitori (11 se il padre ne fruisce almeno 3), fino ai 12 anni del bambino	INPS 30% per i primi 9 mesi (con maggiorazioni per i primi 2/3 mesi all'80%)	D.Lgs. 151/01 artt. 32-38
Riposi giornalieri (allattamento)	2 ore al giorno (1 ora se orario giornaliero inferiore a 6 ore) fino a 1 anno del bambino	Retribuiti al 100%	D.Lgs. 151/01 artt. 39-40
Congedo per malattia del bambino	Senza limiti fino a 3 anni; 5 giorni/anno per ciascun genitore dai 3 agli 8 anni	Non retribuito (ma coperto da contribuzione figurativa)	D.Lgs. 151/01 artt. 47-52
Permesso non retribuito aggiuntivo TD	Fino a 30 giorni aggiuntivi all'anno, frazionabili, per esigenze familiari documentate legate alla genitorialità	Non retribuito, con conservazione del posto	Politica aziendale TD (PLN002)

5.2 Divieto di licenziamento

La lavoratrice madre non può essere licenziata dall'inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino (D.Lgs. 151/2001 art. 54). Il divieto opera anche in caso di mancata comunicazione dello stato di gravidanza al datore di lavoro, purché la gravidanza sia in corso alla data del licenziamento. Il divieto non si applica nei casi di giusta causa, cessazione dell'attività aziendale, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta (contratto a

termine), esito negativo della prova. Le dimissioni della lavoratrice durante il periodo protetto devono essere convalidate dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

6. Gestione organizzativa durante il congedo

La funzione P&C, in collaborazione con il responsabile di area, pianifica per tempo la copertura della posizione durante il congedo, adottando una o più delle seguenti soluzioni: redistribuzione temporanea delle attività tra i colleghi del team, con eventuale riconoscimento dell'aggravio (straordinario autorizzato o indennità di funzione temporanea); assunzione a tempo determinato in sostituzione (motivazione: sostituzione maternità, con indicazione del nominativo della lavoratrice sostituita nella lettera di assunzione); ricorso alla somministrazione di lavoro per le sostituzioni di breve durata o per profili di difficile reperimento; riorganizzazione temporanea dei turni e dei carichi di lavoro. La scelta della soluzione è concordata tra P&C, il responsabile di area e l'AD, tenendo conto delle esigenze operative e della tutela della qualità del servizio.

7. Rientro dalla maternità

7.1 Piano di rientro

Il rientro dalla maternità è un momento delicato che merita la stessa attenzione dell'onboarding iniziale. La funzione P&C contatta la lavoratrice almeno 30 giorni prima della data prevista di rientro per concordare le modalità di ripresa, con particolare attenzione a: conferma della mansione e della sede di lavoro (la lavoratrice ha diritto al rientro nella stessa unità produttiva e nella stessa mansione, o in mansione equivalente, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 151/2001); definizione dell'orario di lavoro, tenendo conto delle esigenze di allattamento (riposi giornalieri) e delle eventuali richieste di part-time temporaneo; aggiornamento professionale sulle novità intervenute durante l'assenza (nuove procedure SGI, nuovi sistemi informatici, nuove apparecchiature, variazioni organizzative); visita medica di idoneità alla mansione da parte del Medico Competente (obbligatoria dopo assenza superiore a 60 giorni continuativi ai sensi dell'art. 41 c.2 lett. e-ter del D.Lgs. 81/2008).

7.2 Flessibilità e conciliazione

Toscana Diagnostica promuove la conciliazione vita-lavoro per i genitori attraverso le seguenti misure, in coerenza con la UNI PdR 125 e il Piano PdG (PLN002): possibilità di richiedere la trasformazione temporanea del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, fino al compimento del terzo anno di età del bambino, compatibilmente con le esigenze organizzative (con diritto di reversibilità); flessibilità in ingresso e in uscita (fino a 60 minuti di elasticità sull'orario di ingresso, da recuperare in giornata), previa autorizzazione del responsabile; priorità nella scelta dei turni e nella pianificazione delle ferie per i genitori con figli fino a 3 anni; possibilità di svolgere in modalità di lavoro agile (smart working) le attività compatibili con la presenza da remoto (attività amministrative, refertazione, formazione), previa autorizzazione e nel rispetto della policy aziendale.

8. Tutela della lavoratrice madre fino a sette mesi dopo il parto

Le misure di protezione previste dalla Sezione 4 si applicano non solo durante la gravidanza ma anche fino a sette mesi dopo il parto per i rischi biologico, chimico e radiologico. In particolare, la lavoratrice madre che rientra al lavoro prima del settimo mese dopo il parto continua a essere esclusa dalle mansioni a rischio elencate nella Sezione 4 e mantiene l'assegnazione a mansione compatibile. Il RSPP e il Medico Competente rivalutano la posizione lavorativa al termine del settimo mese, confermando o revocando le restrizioni.

9. Adozione e affidamento

I congedi e le tutele previsti dalla presente procedura si applicano, con gli adattamenti previsti dalla legge, anche ai genitori adottivi e affidatari. Il congedo di maternità obbligatorio decorre dall'ingresso del minore in famiglia (per l'adozione nazionale) o dall'ingresso in Italia (per l'adozione internazionale) e ha la medesima durata di 5 mesi. Il congedo parentale decorre dall'ingresso del minore in famiglia e può essere fruito entro 12 anni dall'ingresso, a condizione che il minore non abbia superato i 18 anni. La funzione P&C fornisce supporto informativo e amministrativo per le pratiche di adozione e affidamento, inclusi i congedi per i periodi di permanenza all'estero.

10. Matrice delle responsabilità (RACI)

R = Responsabile, A = Approvatore, C = Consultato, I = Informato.

Attività	P&C	RSPP	Med. Comp.	Resp. area	Lavoratrice
Ricezione comunicazione gravidanza	R	I	I	I	R
Valutazione rischi individuale	C	R	R	C	I
Spostamento a mansione compatibile	R	C	C	R	I
Richiesta interdizione anticipata ITL	R	C	C	I	C
Gestione congedi e permessi INPS	R	I	I	I	R
Pianificazione copertura posizione	R	I	I	C	I
Colloquio pre-rientro (30 gg prima)	R	I	I	C	R
Visita medica di rientro	C	C	R	I	R
Aggiornamento professionale al rientro	C	I	I	R	R
Valutazione richieste part-time / flessibilità	R	I	I	C	R

11. Indicatori di processo

Valutazione rischi completata entro 5 gg dalla comunicazione: Obiettivo: 100%.

Colloqui pre-rientro effettuati almeno 30 gg prima: Obiettivo: 100%.

Richieste di part-time post-maternità accolte: percentuale. Monitoraggio trend.

Dimissioni entro 12 mesi dal rientro dalla maternità: percentuale. Obiettivo: ≤ 5%.

Gender pay gap pre/post maternità: Obiettivo: 0% (nessuna penalizzazione retributiva).

Reclami o segnalazioni per discriminazione legata alla maternità: Obiettivo: zero.

12. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione modifiche	Approvazione
00	12/04/2026	Prima emissione	Francesco Epifani
01	04/05/2026	Allineamento al CCNL Studi Professionali (Confprofessioni) effettivamente applicato a TD: sostituiti i riferimenti errati a CCNL AIOP. La tutela della genitorialità e i congedi obbligatori restano disciplinati dal D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità/paternità) con integrazione al 100% della retribuzione nei limiti previsti dal CCNL Studi Professionali.	RSGI / AD